

1. L'angor stable est défini comme la survenue imprévisible d'une sensation d'oppression thoracique ou d'étouffement lors d'effort physiques ou d'émotions.	1. Faux
2. L'angor stable peut se manifester par des éructations, des nausées ou de la fatigue.	2. Vrai
3. On parle d'angor chronique stable quand les symptômes sont stables depuis au moins 1 an.	3. Faux
4. Les symptômes de l'angor chronique stable cèdent après 10 à 15 minutes de repos.	4. Faux
5. Les dérivés nitrés sublinguaux aident à faire passer les symptômes de l'angor car le NO est un vasodilatateur.	5. Vrai
6. L'athérosclérose coronaire sévère est une cause fréquente d'angine de poitrine chronique stable.	6. Vrai
7. Les symptômes de l'angor stable sont provoqués par un rétrécissement d'au moins 75% du diamètre d'une artère coronaire endocardique.	7. Faux
8. L'angine de poitrine est induite par un apport insuffisant d'oxygène lors de périodes de demande accrue.	8. Vrai
9. Les forces de cisaillement du flux sanguin induisent la libération de NO par les cellules endothéliales.	9. Vrai
10. Le débit coronaire peut augmenter jusqu'à 4 fois pendant l'effort physique.	10. Faux
11. L'angor stable est souvent induit par une athérosclérose coronaire légère.	11. Faux

12. Les symptômes de l'angor stable surviennent toujours dans les mêmes circonstances.	12. Vrai
13. Le débit coronaire peut être augmenté par la libération d'adénosine et de NO afin de dilater les coronaires.	13. Vrai
14. Les épisodes d'ischémie myocardique sont rarement asymptomatiques.	14. Faux
15. L'adénosine est produite à partir de la dégradation d'ATP et sert à diminuer les résistances coronaires quand la consommation d'énergie augmente.	15. Vrai
16. L'ischémie myocardique survient préférentiellement après le repas en début d'après-midi.	16. Faux
17. L'angor est favorisé par une dysfonction endothéliale coronaire provoquée par l'athérosclérose.	17. Vrai
18. Une ischémie myocardique peut survenir en présence d'artères coronaires épigardiques normales.	18. Vrai
19. L'hyperviscosité sanguine et l'anémie sévère peuvent causer une angine de poitrine.	19. Vrai
20. L'hypothyroïdie augmente les besoins en oxygène du myocarde et peut provoquer un angor d'effort.	20. Faux
21. Un cœur hypertrophié est plus sujet à l'angine de poitrine.	21. Vrai
22. Les épisodes d'ischémie myocardique asymptomatiques surviennent surtout entre 6 et 10h du matin.	22. Vrai
23. Le froid peut déclencher les symptômes de l'angor chronique stable.	23. Vrai
24. Les examens complémentaires sont indispensables au diagnostic de l'angor stable.	24. Faux
25. Les douleurs thoraciques de l'angor stable sont généralement rétro-sternales et irradiées vers le bras gauche.	25. Vrai

26. L'angor stable de classe IV survient au repos.	26. Vrai
27. L'examen clinique est souvent suffisant pour exclure les causes secondaires d'angor.	27. Vrai
28. L'oxygénation du myocarde se fait principalement en systole.	28. Faux
29. La pression intra-myocardique épicardique est généralement plus élevée que la pression sous-endocardique.	29. Faux
30. Le flux sanguin épicardique est plus élevée que le flux sanguin endocardique pendant la systole.	30. Vrai
31. Une pression diastolique augmentée s'oppose à la perfusion sous-endocardique.	31. Vrai
32. L'ischémie myocardique prédomine dans la région sous-endocardique, ce qui se traduit par un sus-décalage horizontal >1mm du segment ST à l'ECG.	32. Faux
33. L'ECG au repos est anormal chez la majorité des patients atteints d'angine de poitrine chronique stable.	33. Faux
34. L'ECG à l'effort est toujours réalisé pour le diagnostic d'angor instable.	34. Faux
35. L'échographie cardiaque est utilisée pour rechercher une altération de la fonction ventriculaire si l'ECG de repos est normal.	35. Faux
36. L'ECG à l'effort montre un sous-décalage horizontal ou descendant >1mm du segment ST en cas d'angor.	36. Vrai
37. La scintigraphie myocardique utilise des traceurs de perfusion pour évaluer le flux sanguin myocardique.	37. Vrai
38. La scintigraphie myocardique est réalisée au repos.	38. Faux

39. La dobutamine est un bêta-bloquant utilisé pour simuler un exercice physique pendant les examens du cœur.	39. Faux
40. L'angor de classe I survient pour des efforts habituels.	40. Faux
41. Le dipyridamole ou la dobutamine sont utilisés pour réaliser un CT-coronaire chez les patients qui ne peuvent pas réaliser un effort à cause d'une artérite des membres inférieurs ou d'un problème orthopédique.	41. Faux
42. Le dipyridamole IV empêche la dégradation de l'adénosine endogène pour vasodilater les artères coronaires normales et induire un phénomène de vol coronaire dans les régions ischémiques. L'asymétrie de perfusion est le signe d'une sténose coronaire.	42. Vrai
43. Le CT-coronaire nécessite l'administration d'un produit de contraste iodé dans une artère du bras.	43. Faux
44. Le CT-coronaire a une excellente valeur prédictive positive donc on peut exclure la sténose si il est normal.	44. Faux
45. L'irradiation engendrée par une coronarographie est plus élevée que pour un CT-coronaire.	45. Vrai
46. Le CT-coronaire permet d'évaluer la perméabilité des stents métalliques.	46. Faux
47. Le CT-coronaire nécessite que le patient soit à jeun, avec un rythme cardiaque pas trop rapide ou irrégulier et qu'il sache effectuer une apnée volontaire.	47. Vrai
48. Une coronarographie est effectuée chez la majorité des patients angoreux.	48. Faux
49. La coronarographie nécessite l'injection intraveineuse de produit de contracte iodé.	49. Faux

50. La coronarographie est un examen invasif avec un risque d'embolisation de plaques d'athérome aortiques.	50. Vrai
51. L'OCT est une technique d'imagerie intra-coronaire utilisée pour évaluer la perméabilité des stents coronaires.	51. Faux
52. Les antiagrégants plaquettaires sont généralement prescrits dans le traitement de l'angor stable.	52. Vrai
53. L'aspirine est prescrite en 2 ^{ème} intention si le patient présente une contre-indication au clopidogrel.	53. Faux
54. Les bêta-bloquants sont prescrits à tous les patients angoreux (sauf contre-indications).	54. Vrai
55. La dilatation coronaire percutanée (PTCA) est utilisée comme traitement curatif pour l'angor chronique stable.	55. Faux
56. La dilatation coronaire percutanée est proposée si l'angor persiste malgré un traitement médical optimal.	56. Vrai
57. La PTCA utilise un ballon gonflé à 2 atmosphères pour écraser la plaque d'athérome et poser un stent.	57. Faux
58. Le dinitrate d'isosorbide est utilisé sous forme orale ou transdermique dans le traitement de l'angor stable.	58. Vrai
59. Une association de 2 antiagrégants plaquettaires (aspirine + clopidogrel) est nécessaire pendant quelques mois après une dilatation coronaire.	59. Vrai
60. Les pontages coronariens chirurgicaux sont recommandés pour les lésions coronaires monotronculaires.	60. Faux
61. Le traitement de l'angine de poitrine chronique stable vise notamment à supprimer les crises d'angor.	61. Vrai
62. L'arrêt du tabac est recommandé comme traitement de 1 ^{ère} intention pour l'angor chronique stable.	62. Vrai
63. La dilatation coronaire percutanée est souvent réalisée en cas d'échec du traitement médical.	63. Vrai

64. Les stents coronaires réduisent le risque de resténose de 30-40% à <20% endéans les 6 mois.	64. Vrai
65. Les pontages coronariens chirurgicaux sont indiqués pour les lésions coronaires tritronculaires seulement si elles sont associées à une altération de la fonction systolique ventriculaire gauche (FEVG <50%).	65. Faux
66. La sténose du tronc commun coronaire gauche n'est pas une indication chirurgicale.	66. Faux
67. Le risque de resténose après dilatation coronaire est plus élevé chez les patients diabétiques.	67. Vrai
68. Les stents coronaires sont souvent enrobés d'un agent anti-mitotique comme le tacrolimus pour réduire le risque de resténose à quelques %.	68. Vrai
69. L'aspirine ne peut jamais être associée au clopidogrel.	69. Faux
70. Les lésions tritronculaires qui atteignent les artères interventriculaire antérieure proximale, circonflexe et coronaire droite sont une indication de pontage coronaire chirurgical.	70. Vrai
71. Le contrôle des facteurs de risques (dyslipidémie, HTA,...) est essentiel dans le traitement de l'angor.	71. Vrai
72. Le spasme artériel de l'angor spastique induit une ischémie rarement mortelle.	72. Vrai
73. L'angor variant survient principalement pendant l'exercice.	73. Faux
74. Les spasmes des artères coronaires sont plus fréquents entre 8h du soir et minuit.	74. Faux
75. L'angine de poitrine spastique est plus fréquente chez les hommes.	75. Faux

76. La majorité des patients atteints d'angor spastique n'ont pas de lésions athéromateuses coronaires.	76. Faux
77. Les dérivés nitrés et les antagonistes calciques sont efficaces dans le traitement de l'angor spastique.	77. Vrai
78. Le spasme artériel survient après l'effort (et pas pendant) chez 30% des patients atteints d'angor spastique.	78. Vrai
79. Le spasme artériel dans l'angine de poitrine spastique est toujours dû à une athérosclérose coronaire.	79. Faux
80. Dans l'angor spastique, le segment ST est sus-décalé en raison d'une ischémie légère sous-endocardique.	80. Faux
81. Les bêta-bloquants sont recommandés dans le traitement chronique de l'angine de poitrine spastique.	81. Faux
82. Les tachyarythmies ventriculaires surviennent lors de la reperfusion des artères coronaires spastiques.	82. Vrai
83. La cocaïne, le tabac, l'alcool ou l'hypoventilation peuvent déclencher l'angine de poitrine spastique.	83. Faux
84. La coronarographie est inutile dans le diagnostic de l'angine de poitrine spastique.	84. Faux
85. Il faut éviter les bêta-bloquants en cas d'angor spastique car ils favorisent le spasme artériel en antagonisant les récepteurs bêta-2 adrénergiques vasoconstricteurs.	85. Faux
86. Les antagonistes calciques sont contre-indiqués dans le traitement chronique de l'angine de poitrine spastique.	86. Faux
87. Un test de provocation des spasmes par l'hyperventilation, l'ergonovine ou l'acétylcholine intra-coronaire peut être proposé pour le diagnostic d'angine de poitrine spastique.	87. Vrai
88. L'angor variant est de bon pronostic si il n'est pas associé à des lésions coronaires athéroscléreuses.	88. Vrai

89. Dans l'angor spastique, le segment ST est sous-décalé en raison d'une ischémie sévère et transmurale.	89. Faux
90. Le Holter est très utile pour diagnostiquer un angor de Prinzmetal.	90. Vrai
91. L'hypertension artérielle induit un amincissement de la média des artérioles.	91. Faux
92. Les artères épicaudiques sont normales à la coronarographie en cas d'angine de poitrine microvasculaire.	92. Vrai
93. L'angine de poitrine microvasculaire est souvent associée à des pathologies valvulaires.	93. Vrai
94. La dilatation ventriculaire et la diminution de pression intra-cavitaire réduisent la perfusion coronaire.	94. Faux
95. Les femmes sont plus fréquemment touchées par l'angine de poitrine microvasculaire que les hommes.	95. Vrai
96. Les douleurs de l'angine de poitrine microvasculaire répondent généralement bien aux dérivés nitrés.	96. Faux
97. L'échographie cardiaque montre souvent une altération de la cinétique ventriculaire sous perfusion de dobutamine chez les patients atteints d'angine de poitrine microvasculaire.	97. Faux
98. L'angor microvasculaire est souvent associée au syndrome dysmétabolique ou à l'anxiété.	98. Vrai
99. Le diabète sucré peut causer une angine de poitrine microvasculaire.	99. Vrai
100. La coronarographie est souvent anormale chez les patients atteints d'angine de poitrine microvasculaire.	100. Faux
101. Les dérivés nitrés sont efficaces chez la moitié des patients atteints d'angine de poitrine microvasculaire.	101. Vrai
102. Les bêta-bloquants sont contre-indiqués dans le traitement de l'angine de poitrine microvasculaire.	102. Faux

103. L'aminophylline bloque les récepteurs à l'adénosine et est utilisée dans le traitement de l'angine de poitrine microvasculaire.	103. Vrai
104. L'imipramine est un antidépresseur tricyclique utilisé en 1 ^{ère} intention dans le traitement de l'angine de poitrine microvasculaire pour bloquer la perception de la douleur.	104. Faux
105. Le pronostic de l'angine de poitrine microvasculaire dépend de la gravité de l'affection sous-jacente.	105. Vrai
106. La scintigraphie myocardique au thallium montre des déficits de perfusion chez 50% des cas d'angor microvasculaire.	106. Faux
107. L'angine de poitrine microvasculaire se manifeste par des douleurs thoracique intenses et brèves.	107. Faux
108. L'enregistrement ambulatoire du rythme cardiaque (Holter) montre fréquemment des sous-décalages asymptomatiques du segment ST chez les patients coronariens.	108. Vrai
109. La mort subite est la 1 ^{ère} manifestation de la pathologie coronaire chez 30% des patients coronariens.	109. Faux
110. L'angine de poitrine asymptomatique est rarement détectée chez les patients traités.	110. Faux
111. Les activités routinières qui augmentent des demandes en oxygène peuvent provoquer une ischémie myocardique asymptomatique.	111. Vrai
112. La mort subite est rarement la première manifestation de la pathologie coronaire.	112. Faux

113. La moitié des morts subites ne sont pas précédées de symptômes coronaires.	113. Vrai
114. Les patients diabétiques ont une sensibilité réduite à la douleur à cause d'une neuropathie autonome.	114 . Vrai
115. L'épreuve d'effort est généralement négative chez les patients atteints d'angor asymptomatique.	115. Faux
116. L'ischémie asymptomatique est de meilleur pronostic que l'ischémie symptomatique.	116. Faux
117. L'enregistrement du rythme cardiaque permet de détecter un sus-décalage du segment ST.	117. Faux
118. La persistance d'une ischémie silencieuse prédit un risque accru d'évènements coronaires et de mort cardiaque.	118. Vrai
119. L'angine de poitrine silencieuse prédomine le matin en raison d'une augmentation concomitante du rythme cardiaque et de la pression artérielle.	119. Vrai
120. Les modifications à l'ECG précèdent la douleur durant l'ischémie myocardique	120. Vrai
121. Les ischémies peu sévères et peu prolongées sont insuffisantes pour provoquer de la fibrose.	121. Faux
122. Les ischémies asymptomatiques témoignent de l'instabilité de la plaque athéromateuse.	122. Vrai
123. Le traitement de l'angine de poitrine silencieuse vise surtout à supprimer les épisodes symptomatiques pour améliorer la qualité de vie du patient.	123. Faux
124. L'angine de poitrine asymptomatique est un indicateur de mauvais pronostic.	124. Vrai

125. Les statines ne sont pas utiles dans le traitement de l'angine de poitrine asymptomatique.	125. Faux
126. Les dérivés nitrés sont administrés en continu pour éviter les épisodes d'ischémie asymptomatique.	126. Faux
127. Les bêta-bloquants suppriment totalement l'ischémie chez 60% des patients atteints d'angine de poitrine asymptomatique.	127. Vrai
128. Les antagonistes calciques à longue durée d'action sont à éviter dans le traitement de l'angine de poitrine silencieuse car ils induisent une tachycardie réflexe.	128. Faux
129. Les antiagrégants plaquettaires sont nécessaires dans le traitement de l'angor asymptomatique.	129. Vrai
130. Les patients diabétiques sont plus susceptibles de présenter une angine de poitrine asymptomatique.	130. Vrai
131. Le Holter enregistre des sous-décalages > 1mm du segment ST de plus d'une minute et séparé de 1 minute de l'évènement précédent en cas d'angine de poitrine silencieuse.	131. Vrai
132. L'ischémie silencieuse peut être confirmée par la scintigraphie myocardique de perfusion ou par l'échographie cardiaque de stress sous dobutamine.	132. Vrai
133. Les dérivés nitrés doivent être administrés avec une fenêtre thérapeutique de 10 à 12 heures pour éviter une perte d'efficacité par un phénomène de tolérance.	133. Vrai
134. Certains antagonistes calciques peuvent être associés avec des bêta-bloquants.	134. Vrai

135. Les statines sont importantes dans le traitement de l'angine de poitrine asymptomatique.	135. Vrai
136. L'angor instable est trois fois plus fréquent que l'infarctus myocardique avec élévation ST.	136. Vrai
137. L'infarctus NSTEMI est caractérisé par une ischémie transmurale du myocarde.	137. Faux
138. L'ECG de l'infarctus NSTEMI montre une onde Q de nécrose.	138. Faux
139. L'angor instable peut se compliquer par une mort subite suite à une arythmie ventriculaire.	139. Vrai
140. Les patients atteints d'angor instable ont un risque important de réinfarctissement.	140. Vrai
141. L'infarctus NSTEMI est provoqué par une réduction sévère ou un arrêt permanent de l'apport sanguin.	141. Faux
142. Il n'y a pas d'élévation du segment ST et pas d'onde Q à l'ECG en cas d'angor instable.	142. Vrai
143. Les lésions d'angor instable sont souvent diffuses et ne traversent pas la paroi ventriculaire.	143. Vrai
144. Les symptômes de l'angine de poitrine instable sont souvent moins sévères mais plus prolongés que ceux de l'angor chronique stable.	144. Faux
145. Les symptômes de l'angor instable peuvent durer jusqu'à plus d'une heure.	145. Faux
146. L'angor instable est parfois asymptomatique.	146. Vrai
147. Les dérivés nitrés sublinguaux sont très efficaces pour soulager la douleur dans l'angor instable.	147. Faux
148. L'angine de poitrine instable survient principalement pendant l'effort.	148. Faux

149. L'angor instable survient suite à l'embolisation distale d'un thrombus formé par la fissuration d'une plaque athéro-sclérotique.	149. Vrai
150. Les symptômes surviennent souvent la nuit dans l'angor stable.	150. Faux
151. L'ECG montre un sous-décalage du segment ST dans l'angine de poitrine instable.	151. Vrai
152. L'angor instable est caractérisé par des symptômes d'apparition récente, en aggravation ou de repos.	152. Vrai
153. Les infections, la fièvre et l'hypoxémie favorisent les crises d'angor instable.	153. Vrai
154. L'amplitude de l'onde R augmente après quelques heures/jours en cas d'infarctus NSTEMI.	154. Faux
155. Le sous-décalage du segment ST est accompagné par des ondes T positives, symétriques et profondes à l'ECG en cas d'infarctus NSTEMI.	155. Faux
156. La nécrose est uniquement sous-endocardique dans les lésions NSTEMI.	156. Vrai
157. L'examen clinique est souvent banal en cas d'angine de poitrine instable.	157. Vrai
158. Le sous-décalage du segment ST persiste après un infarctus STEMI.	158. Faux
159. En cas d'angor instable, la présence de séquelles anciennes d'infarctus avec onde Q à l'ECG témoignent de la présence d'une cardiopathie hypertrophique.	159. Faux
160. Il est impossible d'exclure un syndrome coronarien aigu sur base des marqueurs biologiques.	160. Vrai

161. La troponine est élevée dans l'angor instable.	161. Faux
162. Les troponines H et T sont très sensibles et spécifiques pour le myocarde.	162. Faux
163. La troponine est un marqueur d'ischémie myocardique plus sensible que les CK-MB.	163. Vrai
164. Les troponines augmentent immédiatement après l'ischémie myocardique et restent élevées >2 semaines.	164. Faux
165. L'amplitude de l'onde Q diminue quelques jours après l'infarctus NSTEMI à cause de la perte de fibres myocardiques.	165. Faux
166. Aucun marqueur biologique n'est suffisamment sensible pour exclure un syndrome coronarien aigu.	166. Vrai
167. La mesure de CK-MB est utilisée pour le diagnostic différentiel de l'angor instable et de l'infarctus NSTEMI.	167. Faux
168. 30% des patients qui ont un NSTEMI ne sont pas diagnostiqués sur base de la clinique, de l'ECG et de l'absence d'élévation d'enzymes moins sensibles que la troponine.	168. Vrai
169. Les nouveaux dosages ultrasensibles de troponine sont exprimés en µg/L.	169. Faux
170. Des prélèvements répétés sont nécessaires pendant les 12 premières heures de l'infarctus pour mesurer une élévation dynamique de la troponine.	170. Vrai
171. L'infarctus NSTEMI entraîne des modifications réversibles de l'ECG.	171. Vrai
172. Un taux de troponine augmentée signifie un risque cardiovasculaire augmenté à long terme.	172. Vrai

173. L'augmentation de la CRP et du plasminogène prédit le risque de complications ultérieures en cas d'infarctus NSTEMI.	173. Faux
174. L'élévation de la troponine est un signe spécifique de l'infarctus myocardique.	174. Faux
175. D'autres enzymes cardiaques comme la LDH ou la CPK peuvent augmenter en cas d'infarctus NSTEMI.	175. Vrai
176. L'échographie cardiaque est utilisée pour diagnostiquer l'angine de poitrine instable.	176. Faux
177. Les tests fonctionnels sont réalisés immédiatement après la stabilisation des symptômes pour évaluer l'impact de l'infarctus NSTEMI et adapter le traitement.	177. Faux
178. La coronarographie est réalisée chez tous les patients atteints d'angor instable.	178. Faux
179. Le traitement médical aigu de l'infarctus NSTEMI vise à réduire la douleur, limiter la nécrose et prévenir les récurrences.	179. Vrai
180. L'effet inotrope négatif des bêta-bloquants est favorable pour diminuer la consommation d'oxygène du cœur en cas d'angor instable.	180. Vrai
181. L'héparine non fractionnée ou de bas poids moléculaire est indiquée dans le traitement aigu de l'angor instable ou de l'infarctus NSTEMI.	181. Vrai
182. L'aspirine est utilisée pour réduire l'inflammation dans l'angor instable.	182. Faux

183. Les patients atteints d'infarctus sont généralement hospitalisés pendant 2 semaines.	183. Faux
184. On administre de l'oxygène nasal à tous les patients atteints d'angor instable.	184. Faux
185. La fibrillation auriculaire est un facteur associé à un mauvais pronostic dans l'angor instable.	185. Vrai
186. Les troponines augmentent plus de 3 heures après l'infarctus NSTEMI.	186. Vrai
187. Des diurétiques et des inhibiteurs de l'enzyme de conversion peuvent être administrés en cas d'infarctus NSTEMI pour agir contre l'insuffisance cardiaque.	187. Vrai
188. Une coronarographie est effectuée 48h après un infarctus NSTEMI chez les patients à risque élevé.	188. Faux
189. Des fluctuations du segment ST au repos sont associés à un mauvais pronostic en cas d'angor instable.	189. Vrai
190. Les anti-thrombotiques sont indispensables dans le traitement de l'angor instable.	190. Vrai
191. Le retour à domicile dans les 3 à 7 jours est possible dans 95% des cas après un infarctus NSTEMI.	191. Vrai
192. Les bêta-bloquants sont contre-indiqués si la PAS est > 100 mmHg et le RC < 60 bpm.	192. Faux
193. Les dihydropyridines peuvent être associés aux bêta-bloquants dans le traitement aigu de l'angor instable.	193. Vrai
194. La morphine est utilisée pour réduire la douleur dans l'angor instable.	194. Vrai
195. Le clopidogrel est un agoniste des récepteurs à l'ADP plaquettaire et exerce une action anti-thrombotique.	195. Faux
196. Le traitement médical permet de limiter la mortalité aiguë de l'infarctus NSTEMI à < 1%.	196. Faux

197. Le LDL-cholestérol doit être réduit <115mg/dl avec des statines (±ézétimibe) après un infarctus NSTEMI.	197. Faux
198. 1/4 des patients doivent bénéficier d'une revascularisation coronaire dans l'année après un épisode d'angor instable.	198. Vrai
199. Le clopidogrel doit être associé à l'aspirine pendant un an après un infarctus NSTEMI.	199. Vrai
200. L'aspirine à petite dose inhibe l'agrégation des plaquettes par une acétylation réversible de la cyclooxygénase plaquettaire.	200. Faux
201. L'aspirine inhibe la production de thromboxane A2 et réduit le thrombus au niveau des lésions athéromateuses.	201. Vrai
202. La prise d'aspirine réduit le risque relatif de décès et d'infarctus de >70% après un épisode d'angor instable.	202. Faux
203. Les bêta-bloquants sont administrés par voie orale dans le traitement aigu de l'angor instable.	203. Faux
204. Les héparines de bas poids moléculaire inhibent surtout le facteur de coagulation Xa.	204. Vrai
205. L'héparine non fractionnée a une relation dose-réponse plus fiable que les héparines de bas poids moléculaire.	205. Faux
206. Les héparines de bas poids moléculaire sont administrées par voie sous-cutanée.	206. Vrai

207. Le suivi biologique de l'anticoagulation n'est pas nécessaire pour les héparines de bas poids moléculaire.	207. Vrai
208. Les héparines de bas poids moléculaire réduisent de 50% (en présence d'aspirine) les risque de décès et d'infarctus myocardique en cas d'angor instable.	208. Vrai
209. Le vérapamil est utilisé pour le traitement de l'angor instable en cas de contre-indication aux β -bloquants.	209. Faux
210. La nécrose myocardique survient après environ 20 minutes d'ischémie.	210. Vrai
211. L'infarctus myocardique est généralement dû à une augmentation brutale de la perfusion coronaire dans un territoire myocardique.	211. Faux
212. L'infarctus myocardique est la forme maligne du syndrome coronaire instable.	212. Vrai
213. L'étendue de la nécrose myocardique est souvent plus limitée en cas d'ischémie chronique.	213. Vrai
214. L'instabilité électrique induite par un infarctus peut conduire à la fibrillation ventriculaire et à la mort subite.	214. Vrai
215. L'occlusion de l'artère coronaire conduit immédiatement à une nécrose myocardique.	215. Faux
216. Au plus l'occlusion est proximale, au moins l'étendue de la nécrose sera importante.	216. Faux
217. L'étendue de la nécrose myocardique dépend uniquement du site de l'occlusion.	217. Faux
218. Les infarctus surviennent souvent sur des lésions coronaires peu serrées.	218. Vrai
219. L'infarctus STEMI est dû à la rupture progressive d'une plaque athéromateuse instable et à une thrombose.	219. Faux

220. Les symptômes sont généralement plus sévères en cas d'infarctus STEMI qu'en cas de NSTEMI.	220. Faux
221. L'infarctus STEMI touche plus souvent les femmes de >55 ans.	221. Faux
222. Des nausées, une dyspnée et une transpiration abondante peuvent être associés à l'infarctus.	222. Vrai
223. Le principal symptôme de l'infarctus myocardique est une douleur rétro-sternale violente et non irradiée.	223. Faux
224. L'infarctus est la 1 ^{ère} manifestation de la pathologie coronaire chez 50% des patients.	224. Vrai
225. La douleur thoracique dans l'infarctus dure généralement une vingtaine de minutes.	225. Faux
226. L'infarctus inférieur peut être confondu avec une simple indigestion avec nausées, vomissements et manifestations vagales.	226. Vrai
227. Le système de collatérales développé suite à l'ischémie myocardique chronique n'est généralement pas suffisamment fonctionnel pour limiter la nécrose dans l'infarctus.	227. Faux
228. La pression thoracique ressentie est de la même intensité dans l'infarctus et dans l'angor stable.	228. Faux
229. L'examen physique peut parfois montrer une PA et des bruits cardiaques normaux en cas d'infarctus.	229. Vrai
230. L'infarctus peut se compliquer d'une communication interventriculaire ou d'un œdème pulmonaire.	230. Vrai
231. L'ECG est le seul test nécessaire pour diagnostiquer un infarctus myocardique.	231. Faux
232. La péricardite fait partie du diagnostic différentiel de l'infarctus myocardique.	232. Vrai

233. Les marqueurs biologiques sont plus fiables que l'ECG pour diagnostiquer un infarctus myocardique.	233. Faux
234. Le diagnostic de l'infarctus est avant tout clinique car 10% des patients ont un ECG normal.	234. Vrai
235. Le sous-décalage du segment ST est un signe spécifique de réduction de la perfusion myocardique transmurale.	235. Faux
236. L'infarctus antérieur se manifeste par un sus-décalage du segment ST en D2, aVF et D3.	236. Faux
237. L'infarctus antéro-septal se manifeste par un sus-décalage du segment ST de V1 à V3.	237. Vrai
238. Le segment ST peut être sous-décalé dans certaines dérivations en cas d'infarctus STEMI.	238. Vrai
239. Le sus-décalage du segment ST <1mm dans 2 dérivations adjacentes est le signe le plus spécifique et sensible de la réduction de la perfusion myocardique transmurale.	239. Faux
240. La nécrose atteint toute l'épaisseur du myocarde en cas d'infarctus NSTEMI.	240. Faux
241. L'infarctus antéro-latéral se manifeste par un sus-décalage du segment ST en V5, V6, D1 et aVR.	241. Faux
242. L'infarctus inférieur se manifeste par un sus-décalage du segment ST en D2, aVF et D3.	242. Vrai
243. L'infarctus antérieur étendu se manifeste par un sous-décalage du segment ST de V1 à V6, en D1 et en aVL.	243. Faux
244. L'infarctus apical se manifeste par un sus-décalage en V4.	244. Vrai
245. L'infarctus latéral haut se manifeste par un sus-décalage en aVR.	245. Faux

246. L'évolution temporelle de l'ECG dans l'infarctus transmural montre une augmentation de l'amplitude des ondes T (qui deviennent symétriques) dès les premières heures.	246. Vrai
247. L'examen physique montre généralement une pression artérielle élevée en cas d'infarctus myocardique.	247. Faux
248. L'onde Q de nécrose apparaît dès les premières heures de l'infarctus STEMI.	248. Faux
249. La négativation de l'onde T n'apparaît que après quelques heures/jours en cas d'infarctus STEMI.	249. Vrai
250. Le segment ST redevient isoélectrique quelques semaines après un infarctus myocardique.	250. Vrai
251. Une élévation du segment ST >1mm en V4 est le signe d'un infarctus ventriculaire droit associé à un infarctus myocardique inférieur.	251. Vrai
252. L'amplitude des ondes T augmente au début de l'infarctus STEMI.	252. Vrai
253. Le sus-décalage du segment ST peut atteindre 50% de l'amplitude de l'onde R en cas d'infarctus STEMI.	253. Vrai
254. L'onde Q disparaît quelques mois après un infarctus STEMI.	254. Faux
255. L'onde T reste toujours négative après un infarctus myocardique.	255. Faux
256. Les « ondes T géantes » sont le tout 1 ^{er} signe d'infarctus myocardique à l'ECG (avant l'élévation du ST).	256. Vrai
257. Les ondes Q témoignant d'un infarctus postérieur peuvent se présenter sous la forme d'un sous-décalage en miroir en V1-V3.	257. Vrai

258.	La réduction de l'amplitude de l'onde T persiste des mois après l'infarctus myocardique.	258. Faux
259.	Le diagnostic de l'infarctus à l'ECG est difficile en cas de bloc de branche droit.	259. Faux
260.	La radiographie du thorax est inutile dans le diagnostic de l'infarctus myocardique.	260. Faux
261.	L'échographie cardiaque permet le diagnostic différentiel de l'infarctus STEMI et de la péricardite.	261. Vrai
262.	La présentation clinique ne permet pas de différencier des infarctus STEMI et NSTEMI.	262. Vrai
263.	Les troponines I et T et la CPK (créatine phosphokinase) sont très spécifiques pour le myocarde.	263. Faux
264.	Les troponines s'élèvent en 3 à 12 heures après l'infarctus et se normalisent en 2 à 3 jours.	264. Faux
265.	Les CPK augmentent plus rapidement que les troponines et diminuent plus rapidement en cas de reperfusion coronaire précoce.	265. Vrai
266.	L'échographie cardiaque permet d'évaluer l'altération de la contractilité myocardique après un infarctus.	266. Vrai
267.	Des ondes R amples en V1-V2 à l'ECG peuvent être l'image en miroir d'un infarctus postérieur.	267. Vrai
268.	L'aspartate aminotransférase (SGOT) et la lactate déshydrogénase (LDH) sont d'autres marqueurs biologiques de l'infarctus myocardique avec une cinétique plus lente.	268. Vrai
269.	La morphine est administrée en intra-musculaire pour soulager la douleur de l'infarctus myocardique.	269. Faux
270.	La douleur de l'infarctus STEMI ne cède pas aux dérivés nitrés.	270. Vrai

271. Une dose de charge d'aspirine et de clopidogrel est administrée en urgence en cas d'infarctus STEMI.	271. Vrai
272. Le traitement de l'infarctus aigu vise principalement à rétablir la perméabilité de l'artère thrombosée.	272. Vrai
273. La thrombolyse est toujours préférée à la dilatation percutanée dans le traitement de l'infarctus aigu.	273. Faux
274. La dilatation percutanée est plus efficace que la thrombolyse pour traiter un infarctus aigu du myocarde.	274. Vrai
275. L'administration d'un activateur du plasminogène permet de rouvrir 70% des artères thrombosées en cas d'infarctus.	275. Faux
276. La dilatation percutanée permet de rouvrir 90% des artères thrombosées en cas d'infarctus.	276. Vrai
277. La thrombolyse est associée à un risque d'hémorragie cérébrale.	277. Vrai
278. La thrombolyse est parfois préférable à la dilatation percutanée si les symptômes durent depuis >3h.	278. Faux
279. Le traitement médicamenteux aigu de l'infarctus STEMI est composé de bêta-bloquants, d'héparine de bas poids moléculaire, d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion, de statines et d'antagonistes calciques.	279. Faux
280. Les bêta-bloquants sont contre-indiqués dans le traitement aigu de l'infarctus myocardique.	280. Faux
281. La thrombolyse peut être efficace si le traitement est très précoce et le caillot pas encore consolidé.	281. Vrai
282. Le meilleur traitement de l'infarctus STEMI est la chirurgie coronaire en urgence.	282. Faux
283. Le risque de décès est très important avant le transfert à l'hôpital dans la phase aigüe de l'infarctus.	283. Vrai

284. La dilatation percutanée est toujours préférable à la thrombolyse pour traiter un infarctus myocardique aigu en cas d'insuffisance cardiaque ou de choc cardiogénique.	284. Vrai
285. Les micro-emboles générées par le thrombus contribuent aux lésions myocardiques après un infarctus.	285. Vrai
286. Le ventricule se dilate au niveau de la zone infarctée pour diminuer la tension pariétale.	286. Faux
287. Le myocarde « sidéré » autour de zone de nécrose est normalement perfusé mais ne retrouve pas sa fonction contractile initiale après l'infarctus.	287. Faux
288. L'activation neuro-humorale après l'infarctus provoque une surcharge volémique délétère pour le cœur.	288. Vrai
289. L'activation neuro-humorale est caractérisée par une activation du système rénine-angiotensine-aldostérone et du système orthosympathique et par une augmentation du LDL-cholestérol et de l'ADH.	289. Faux
290. L'échographie cardiaque permet d'évaluer la fonction auriculaire gauche après un infarctus.	290. Faux
291. Une épreuve d'effort sub-maximale permet de rechercher une ischémie résiduelle chez les patients stabilisés après un infarctus STEMI.	291. Vrai
292. La tachycardie ventriculaire et la fibrillation ventriculaire dans les 48h suivant l'infarctus sont des indications de mise en place d'un défibrillateur implantable.	292. Faux
293. Le Holter est utilisée pour observer l'évolution des ondes T après un infarctus STEMI.	293. Faux

294. L'aspirine doit être prise pendant 1 an après un infarctus STEMI.	294. Faux
295. Le clopidogrel doit être associé à l'aspirine pendant au moins 3 à 6 mois après la mise en place d'un stent par angioplastie coronaire.	295. Vrai
296. Les bêta-bloquants doivent être pris à vie après un infarctus aigu du myocarde.	296. Faux
297. On observe un remodelage ventriculaire après un infarctus STEMI.	297. Vrai
298. L'anticoagulation par antivitamine K est recommandée chez tous les patients après un infarctus STEMI.	298. Faux
299. Les héparines de bas poids moléculaire et les bas de contention sont utilisés en prévention de la thrombose veineuse profonde après un infarctus du myocarde.	299. Vrai
300. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion doivent être pris à vie après un infarctus aigu du myocarde.	300. Vrai
301. Les dérivés nitrés sont utilisés dans le traitement chronique de l'infarctus myocardique.	301. Faux
302. Les programmes de réhabilitation cardiaque sont aussi importants que les bêta-bloquants ou les hypocholestérolémiants pour améliorer la survie après un infarctus myocardique.	302. Vrai
303. L'arrêt du tabac ne réduit pas les risques après un infarctus myocardique.	303. Faux
304. Le vérapamil est recommandé dans le traitement chronique de l'infarctus myocardique.	304. Faux
305. La prise chronique d'aspirine réduit la mortalité de 25% après un infarctus STEMI.	305. Vrai

306. Les bêta-bloquants sont utilisés pour augmenter la fréquence cardiaque après un infarctus myocardique.	306. Faux
307. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ne sont pas recommandés pour les patients avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche < 40 %.	307. Faux
308. Il faut réduire le LDL-cholestérol sous 55mg/dl le plus rapidement possible après un infarctus STEMI.	308. Vrai
309. Les anticoagulants sont recommandés uniquement en présence de certaines conditions spécifiques après un infarctus myocardique.	309. Vrai
310. La radiographie du thorax est utile pour évaluer la taille du cœur après un infarctus myocardique.	310. Vrai
311. Les antagonistes calciques sont recommandés pour le traitement aigu de l'infarctus myocardique.	311. Faux
312. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont administrés par voie intraveineuse dans le traitement aigu de l'infarctus myocardique.	312. Faux
313. La prise chronique de bêta-bloquants réduisent la mortalité de 50% après un infarctus STEMI.	313. Faux
314. Les hypocholestérolémians sont recommandés pour réduire le HDL-cholestérol après un infarctus STEMI.	314. Faux
315. Le LDL-cholestérol est faussement abaissé en post-infarctus.	315. Vrai
316. La réduction de la fonction ventriculaire gauche nécessite des inhibiteurs de l'enzyme de conversion.	316. Vrai
317. La prise chronique d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion réduisent la mortalité de 25% post-infarctus.	317. Vrai

318. Le diltiazem est le seul antagoniste calcique recommandé dans le traitement chronique de l'infarctus.	318. Vrai
319. Les dérivés nitrés doivent être arrêtés 48h après un infarctus.	319. Vrai
320. L'administration intra-veineuse d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion augmente la mortalité.	320. Vrai
321. Les arythmies ventriculaires tardives post-infarctus ne sont pas une indication de mise en place d'un défibrillateur implantable.	321. Faux
322. La dissection aortique est 3 fois plus fréquente que la rupture d'un anévrisme aortique abdominal.	322. Faux
323. La dissection aortique est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes.	323. Faux
324. L'HTA est un facteur de risque mineur pour la dissection aortique.	324. Faux
325. La dissection aortique peut être favorisée par une augmentation très rapide de la pression artérielle, comme lors d'un exercice isométrique ou de la prise de cocaïne.	325. Vrai
326. La dissection aortique est rare chez les sujets jeunes, sauf s'ils présentent des facteurs de fragilité tissulaire ou des modifications hémodynamiques.	326. Vrai
327. La dissection aortique touche principalement les hommes entre 40 et 50 ans.	327. Faux
328. La dissection aortique survient principalement dans l'aorte descendante.	328. Faux
329. Dans la classification de Stanford, le Type A concerne l'aorte ascendante et l'arche aortique.	329. Vrai

330. Les sujets atteints de dissection aortique de type A sont souvent hypertendus.	330. Faux
331. La douleur brutale et très sévère est le symptôme le plus fréquent de la dissection aortique.	331. Vrai
332. La grossesse augmente le risque de dissection aortique.	332. Vrai
333. La tricuspide aortique est un facteur de risque de dissection aortique chez les sujets jeunes.	333. Faux
334. Dans la dissection aortique, une fausse lumière se crée entre la média et l'adventice.	334. Faux
335. La déchirure de l'intima touche l'aorte ascendante dans 2/3 des cas de dissection aortique.	335. Vrai
336. La fausse lumière créée par la dissection s'étend au moins sur la moitié de la circonférence aortique.	336. Vrai
337. Les branches de division de l'aorte peuvent parfois être alimentées par la fausse lumière en cas de dissection aortique.	337. Vrai
338. La dissection aortique peut parfois entreprendre la valve mitrale ou les artères coronaires.	338. Faux
339. La dissection aortique de type A de Stanford touche plus souvent les jeunes sans affection prédisposante.	339. Faux
340. Dans la classification de Stanford, le type B touche les vaisseaux après l'artère sous-clavière, c'est-à-dire l'aorte ascendante et l'aorte abdominale.	340. Faux
341. La dissection aortique n'entraîne pas toujours de rupture de l'aorte.	341. Vrai
342. Les sujets atteints de dissection aortique de type B sont souvent âgés et hypertendus.	342. Vrai

343. La dissection aortique se manifeste par une douleur pulsatile et migrante selon l'étendue de la lésion.	343. Faux
344. La dissection aortique peut entraîner une insuffisance aortique aiguë.	344. Vrai
345. La dissection aortique peut être confondue avec un infarctus myocardique.	345. Vrai
346. L'examen physique de la dissection aortique montre un nouveau souffle d'insuffisance aortique.	346. Vrai
347. Le traitement de la dissection aortique de type B nécessite généralement une chirurgie urgente.	347. Faux
348. Le traitement de la dissection aortique de type B est toujours médical.	348. Faux
349. Le traitement chronique de la dissection aortique consiste à traiter l'HTA et à surveiller la taille de l'aorte au moins 2 fois par an par résonance magnétique.	349. Faux
350. L'examen physique de la dissection aortique peut montrer un frottement péricardique.	350. Vrai
351. L'opération de Bentall consiste à remplacer l'aorte ascendante par une prothèse en dacron.	351. Vrai
352. La dissection aortique peut se manifester par des signes d'ischémie des branches de divisions de l'aorte : AVC, syncope, paraplégie, polyurie,...	352. Faux
353. La radiographie de thorax peut montrer une cardiomégalie en cas de dissection aortique.	353. Vrai
354. La dissection aortique peut entrainer le décès du patient par mort subite ou choc (hypovolémique, tamponnade, insuffisance aortique aigue, infarctus myocardique,...).	354. Vrai

355. L'embolie pulmonaire fait partie du diagnostic différentiel de la dissection aortique.	355. Vrai
356. Le traitement en urgence de la dissection aortique comprend une réduction agressive de la PA.	356. Vrai
357. Le scanner spiralé est le meilleur examen pour diagnostiquer une dissection aortique.	357. Faux
358. La prévention de la dissection aortique consiste à traiter l'HTA et à surveiller régulièrement la taille de l'aorte par échographie chez les patients à risque (Marfan, bicuspidie aortique, coarctation aortique,...).	358. Faux
359. Le traitement chronique de la dissection aortique nécessite un contrôle strict de la pression artérielle.	359. Vrai
360. Tous les patients doivent prendre un bêta-bloquant après une dissection aortique.	360. Vrai
361. La cocaïne peut favoriser la survenue d'une dissection aortique en raison de son effet vasodilatateur.	361. Faux
362. La dissection aortique survient principalement chez les personnes jeunes et en bonne santé.	362. Faux
363. La dissection aortique peut entraîner une embolie pulmonaire.	363. Faux
364. L'ischémie des branches de division de l'aorte peut causer une anurie.	364. Vrai
365. La dissection aortique est facilement différenciable de l'infarctus myocardique grâce à l'ECG.	365. Faux
366. La dissection aortique doit être traitée en urgence par l'association d'un bêta-bloquant et d'un vasodilatateur en intra-veineux.	366. Vrai
367. Les personnes atteintes de syndrome de Marfan ont un risque accru de dissection aortique.	367. Vrai

368.	La visualisation de l'arc aortique est parfois difficile à l'échographie.	368. Vrai
369.	La dissection aortique de type A nécessite généralement un traitement médical.	369. Faux
370.	Les personnes atteintes de coarctation aortique ont un risque accru de dissection aortique.	370. Vrai
371.	La dissection aortique peut être confondue avec un abdomen aigu.	371. Vrai
372.	La déchirure de l'intima survient près de l'isthme dans 1/20 des cas de dissection aortique.	372. Faux
373.	La mortalité de la dissection aortique est très élevée en l'absence de traitement.	373. Vrai